

LAPORAN ANALISIS KLINIS

Clinical Decision Support System — AI Doctor

Tanggal Cetak: 20 June 2026, 19:20

1. Identitas Pasien

Nama : Alif
Umur / Gender : 4 tahun / Laki-laki
Berat / Tinggi : 15.0 kg / 100.0 cm
No. RM : RM-017

2. Anamnesis & Pemeriksaan

Keluhan Utama:

Kulit di lipatan siku kiri-kanan gatal hebat dan kemerahan sampai luka karena sering digaruk

Gejala Tambahan:

Anak rewel terutama malam hari, kulit terasa kering, kasar, dan bersisik

Tanda Vital:

Nadi: 96x/m, Suhu: 36.7C, RR: 22x/m

Hasil Laboratorium:

-

Alergi:

Riwayat alergi susu sapi saat bayi

Catatan Bebas Dokter / Keterangan Tambahan:

Tampak plak eritematosa simetris disertai ekskoriasi pada fossa cubiti dextra et sinistra

3. Riwayat Konsultasi Interaktif

[Dokter] Obat kortikosteroid topikal potensi berapa yang aman untuk anak usia 4 tahun dengan berat 15 kg?

[AI] Untuk anak 4 tahun dengan dugaan eksim di lipatan siku, yang paling aman biasanya **kortikosteroid topikal potensi rendah**. Pilihan yang sesuai adalah **hydrocortisone 1% krim**, dioles **tipis 2 kali sehari** selama 5–7 hari pada area merah/gatal, terutama karena lokasinya di area lipatan yang kulitnya lebih sensitif. Berat badan **15 kg** tidak terlalu menentukan potensi steroid topikal; yang lebih penting adalah **usia anak, lokasi lesi, luas area, dan lamanya pemakaian**. Hindari memakai steroid **potensi sedang-kuat** tanpa pemeriksaan langsung dokter, apalagi bila lesi belum pasti bukan jamur. Keputusan akhir tetap di tangan dokter yang memeriksa langsung.

4. Hasil Analisis AI

Kemungkinan Diagnosis:

Diagnosis saat ini masih tentatif, namun paling mungkin adalah dermatitis atopik (eksim fleksural) pada anak. Alasan klinis: gatal hebat, lebih mengganggu malam hari, kulit kering-kasar-bersisik, lesi berupa plak eritematosa simetris dengan ekskoriiasi pada kedua fossa cubiti, serta adanya riwayat atopi keluarga (ibu asma). Temuan lanjutan yang menurunkan kemungkinan skabies adalah tidak ada lesi di sela jari dan tidak ada anggota keluarga yang ikut gatal. Diagnosis banding yang masih perlu dipertimbangkan adalah skabies atipikal, dermatitis kontak, dan tinea corporis bila kemudian ditemukan lesi annular/tepi aktif atau tidak membaik dengan terapi eksem.

Kode ICD-10:

- L20.9 — Atopic dermatitis, unspecified
- L30.9 — Dermatitis, unspecified
- B86 — Scabies
- B35.4 — Tinea corporis

Rekomendasi Terapi:

1. Hydrocortisone krim 1% — oles tipis pada area merah/gatal di lipatan siku 2 kali sehari selama 5-7 hari, lalu evaluasi; potensi rendah lebih aman untuk anak usia 4 tahun pada area lipatan. Hindari pemakaian jangka panjang tanpa kontrol dokter.
2. Emolien/pelembap tebal tanpa pewangi (mis. petrolatum atau krim ceramide) — oles 3-4 kali sehari dan selalu setelah mandi pada seluruh area kulit kering untuk memperbaiki skin barrier.
3. Cetirizine sirup — 2,5 mg per oral 1 kali sehari malam hari selama 5-7 hari bila gatal mengganggu tidur; sesuaikan dengan sediaan yang tersedia dan hentikan bila tidak diperlukan.
4. Non-farmakologi: mandi singkat dengan air suam-suam kuku, gunakan sabun lembut non-pewangi, pakaian katun, potong kuku anak, hindari garukan, keringat berlebih, debu, dan produk kulit berpewangi.
5. Pemeriksaan penunjang terarah bila tidak membaik atau gambaran lesi berubah: evaluasi ulang kemungkinan skabies/jamur sebelum eskalasi terapi steroid topikal.

Saran Pemeriksaan Lanjutan:

- Pemeriksaan kulit menyeluruh lokasi khas skabies (pergelangan tangan, aksila, umbilikus, bokong, genital) — untuk menyingkirkan skabies atipikal meski sela jari negatif dan tidak ada kontak serumah yang gatal.
- Kerokan kulit/KOH dari lesi yang berbatas tegas/annular atau berskuama aktif — untuk menyingkirkan tinea corporis bila respons terhadap terapi eksem kurang baik.
- Evaluasi derajat keparahan dermatitis atopik dan tanda infeksi sekunder (krusta madu, pustul, nyeri, hangat lokal) — karena ada ekskoriiasi akibat garukan.
- Anamnesis faktor pencetus dan riwayat atopi rinci — untuk mengidentifikasi pemicu seperti sabun, deterjen, keringat, debu, makanan tertentu, serta riwayat rinitis alergi/asma/eksim.

Tanda Bahaya / Indikasi Rujukan Segera:

Segera rujuk/periksa ulang bila muncul demam, lesi cepat meluas, kulit bernanah atau berkrusta kuning, nyeri hebat, bengkak, anak tampak lemas, gangguan tidur berat berkepanjangan, atau tidak membaik setelah 1-2 minggu terapi yang sesuai.

berdasarkan pemeriksaan langsung.

Dicetak oleh: AI Doctor System | 20 June 2026, 19:20